BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH CHĂM SÓC DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN

Mã đề xuất CS-TMH-03; bản trình thẩm định 14/10/2026. Chưa ban hành. Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: ……

Áp dụng chăm sóc điều dưỡng theo bệnh, gồm nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Kỹ thuật xâm lấn phải có quy trình riêng theo QĐ3023, chỉ định và người đủ phạm vi/năng lực; bộ này không cho phép điều dưỡng tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

Mã ICD xác định theo vị trí và chẩn đoán của bác sĩ; không dùng T17.2 mặc định cho mọi dị vật đường ăn (cần phân biệt đường thở với thực quản).

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh, lý do đến khám, khởi phát, bệnh nền, thuốc/dị ứng; đánh giá ABCDE, sinh hiệu, đau, ăn/nuốt, dịch vào-ra và nguy cơ té ngã theo tình trạng. Báo ngay khi khó thở, thở rít, tím, giảm ý thức, chảy máu nhiều hoặc dấu giảm tưới máu. Cận lâm sàng theo bác sĩ.

*Hỏi bệnh:

Hỏi loại dị vật, thời điểm, số lượng, pin/nhiễu nam châm/vật sắc, khả năng nuốt nước bọt, đau, nôn và khó thở; không suy vị trí dị vật chỉ từ kiểu thở.

- Triệu chứng đi kèm (nếu có) ? tìm điểm đau ? xác định mức độ tiến triển bệnh ?

- Có bị khàn hay tắc tiếng không ? có ho dữ dội không? Có bị tím tái không ?

-Tiền sử bản thân có mắc bệnh u hay hẹp thực quản không ? có bệnh lý về tâm thần kinh ?

* Khám:

- Nhìn : lồng ngực di chuyển nhanh hay chậm , cân đối hay không, da có tím tái không

- Nghe phổi: tiếng ho khan , ho rít , ho khàn thanh quản ,nghe phổi để tìm triệu chứng thực thể của hô hấp (tiếng ran rít ở cả hai bên phổi, rì rào phế nang giảm ở cả hai bên phổi, cũng có thể có ran ẩm, ran nổ...

- Gõ ngực: Tiếng đục khi có áp xe hoặc xẹp phổi một bên. Gõ trong, vang khi có tràn khí màng phổi.

*Cận lâm sàng :

Bác sĩ lựa chọn nội soi/chẩn đoán hình ảnh và lấy dị vật theo vị trí, tuổi và nguy cơ; điều dưỡng hỗ trợ, không tự thực hiện lấy dị vật.

Chụp theo chỉ định; phim không thấy dị vật không loại trừ dị vật không cản quang.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

2.1. Người bệnh bít tắc đường thực quản do dị vật

2.2. Người người bệnh có nguy cơ apxe tại chỗ hoặc nhiễm trùng toàn thân

2.3.Người bệnh thiếu kiến thức về bệnh

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Đặt mục tiêu cá thể và thời điểm đánh giá: hô hấp/tuần hoàn ổn định, triệu chứng giảm so với ban đầu, dung nạp ăn/uống phù hợp, không xuất hiện dấu nguy hiểm, người bệnh/người chăm sóc hiểu kế hoạch. Phân công người thực hiện và tần suất theo dõi theo nguy cơ/y lệnh.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1 Người bệnh bít tắc đường thực quản do dị vật

Gọi bác sĩ/cấp cứu ngay khi tắc đường thở, không nuốt được nước bọt, pin, vật sắc hoặc nguy cơ thủng. Đánh giá đường thở trước; chuẩn bị can thiệp khẩn theo bác sĩ, không chờ hoàn tất xét nghiệm thường quy.

Cho nhịn ăn uống khi nghi dị vật cần can thiệp và theo y lệnh; không cho nuốt cơm/chuối, uống nước để đẩy dị vật, gây nôn hoặc móc mù.

- Khi có biến chứng phải xử trí và chăm sóc tùy theo từng loại biến chứng.

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn

4.2 Người người bệnh có nguy cơ apxe tại chỗ hoặc nhiễm trùng toàn thân do có vết loét tại chỗ

Thuốc giảm đau, hạ sốt và điều trị khác theo y lệnh; không dùng kháng sinh/kháng viêm thường quy cho mọi trường hợp chưa đánh giá.

Nghi biến chứng: hỗ trợ cấp cứu, theo dõi và báo bác sĩ quyết định chuyển phù hợp năng lực; bảo đảm bàn giao và hỗ trợ vận chuyển, không chỉ tư vấn tự lên tuyến trên.

4.4 Giáo dục sức khỏe

Tuyên truyền cộng đồng:

Không ăn uống vội vàng, không nói chuyện, cười đùa khi ăn.

Trẻ em, người già cần loại bỏ xương trước khi ăn.

Không được chữa mẹo khi hóc.

Thay đổi tập quán chế biến thức ăn: không nên chặt nhỏ thức ăn lẫn xương.

5. Đánh giá

- Bệnh trở về bình thường

- Bệnh khỏe hơn

Ghi kết quả theo từng mục tiêu, triệu chứng/sinh hiệu trước và sau, mức ăn uống và nhu cầu hỗ trợ; điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt hoặc có vấn đề mới. Không ghi chung “khỏe hơn” để thay giá trị theo dõi.

Ghi chép bàn giao và hướng dẫn sau chăm sóc

Ghi nhận định, vấn đề, mục tiêu, thuốc/can thiệp, đáp ứng và thời điểm báo bác sĩ; bàn giao ISBAR, nơi và người tiếp nhận khi chuyển. Hướng dẫn đúng đơn, lịch tái khám cụ thể và dấu nguy hiểm; yêu cầu người chăm sóc nhắc lại. Không đợi hết thuốc khi có dấu xấu đi.

Căn cứ và nội dung cần xác nhận

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . QĐ3023/QĐ-BYT dùng cho đề cương kỹ thuật khi có quy trình kỹ thuật riêng, không dùng để xác lập mọi can thiệp chăm sóc bệnh lý.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.esge.com/removal-of-foreign-bodies-in-the-upper-gastrointestinal-tract-in-adults-european-society-of-gastrointestinal-endoscopy. Áp dụng theo đối tượng và hoàn cảnh của hướng dẫn, không thay thế chỉ định bác sĩ hoặc quy định của bệnh viện.

Khoa TMH xác nhận chẩn đoán/mã ICD, danh mục kỹ thuật được phép, thuốc và kế hoạch theo dõi theo tuổi. Các chẩn đoán điều dưỡng trong nguồn là gợi ý, chỉ chọn khi có dữ liệu thực tế; không mặc định mọi người bệnh đều có tất cả vấn đề.

Người thẩm định/chữ ký/ngày: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……